VITALIS RING

CARE THAT CONNECTS

Dossiê Jurídico e Regulatório

Insumo para consultoria regulatória (ANVISA), LGPD, propriedade intelectual e publicidade

Versão	0.1 — rascunho de trabalho para revisão	Data	19/09/2026
Titular do produto	A confirmar (pessoa jurídica que será titular da marca e fabricante/importadora/distribuidora)	Classificação	Confidencial — uso interno e com assessores

Natureza deste documento. Rascunho elaborado com apoio de IA (Claude) a partir das decisões tomadas no projeto. **Não é parecer jurídico nem regulatório.** As referências normativas foram citadas de memória e precisam ter vigência e aplicabilidade confirmadas por profissional habilitado. O objetivo é reunir o contexto e as perguntas certas para acelerar a análise de advogado(a) e consultoria regulatória.

1. Resumo executivo

- O **Vitalis Ring** é um anel inteligente (hardware OEM, modelo de referência Colmi R10) que mede frequência cardíaca (FC), oxigenação estimada (SpO_2) e movimento, e gera **alertas** a familiares, médicos e instituições por WhatsApp e e-mail.
- O posicionamento pretendido é **produto de estilo de vida/bem-estar que gera alertas**, e não produto médico.
- O escopo atual (limiares clínicos, console médico, venda a hospitais/clínicas, detecção de queda) **tensiona esse posicionamento**. A finalidade de uso é avaliada pelo que o produto promete e como é vendido; rótulo e avisos legais não alteram a classificação.
- Estratégia proposta (a validar): **duas camadas** — camada pública de bem-estar e módulo clínico restrito, liberado só após parecer regulatório.
- Decisão de negócio já tomada: **não registrar a marca no INPI por ora**; o domínio será registrado. Este dossiê inclui esse ponto para avaliação de risco.

Riscos priorizados

#	Risco	Por que importa	Grav.	Ação sugerida
1	Enquadramento como dispositivo médico (hardware e software)	Comercializar sem regularização, se aplicável, expõe a sanções e retirada de produto	Alta	Parecer regulatório antes de qualquer beta com usuários reais
2	Tratamento de dado de saúde (LGPD)	Dado pessoal sensível, em volume contínuo, de idosos e terceiros	Alta	RIPD, encarregado, consentimento, contratos B2B (seção 7)
3	Comunicação e claims (CDC, CONAR, ANVISA)	O copy do site pode caracterizar finalidade médica ou publicidade enganosa	Média-alta	Guia de copy (Anexo A) e revisão jurídica das páginas
4	Marca sem busca de anterioridade/registro	Nome comum em saúde; sistema de marcas atributivo	Média	Busca de anterioridade antes de investir em identidade (seção 9)
5	Canal médico e ética profissional	Remuneração/indicação e telemonitoramento têm regras do CFM	Média	Manter modelo A; parecer antes de qualquer remuneração (seção 8)
6	Terceiros: fabricante OEM, Meta/WhatsApp, nuvem	Homologação, garantias, políticas de uso e transferência internacional	Média	Verificações e contratos (seção 11)

#	Risco	Por que importa	Grav.	Ação sugerida
7	Responsabilidade por falha de alerta	Alerta não entregue ou falso negativo pode gerar expectativa e dano	Média-alta	Termos claros de não emergência, SLA e seguro (seção 11)

2. Produto e escopo funcional

Componente	Descrição	Observações
Anel	Hardware OEM (referência: Colmi R10). Mede FC, SpO_2 e movimento. Sem tela.	Recursos adicionais estão em **validação** (não bloqueia o desenvolvimento). Sem ECG e sem promessa de diagnóstico.
Coleta	Leitura por Bluetooth Low Energy (BLE) e envio ao servidor	MVP validado em bancada com leituras reais
Servidor/API	Recebe dados quase em tempo real; atualização sob demanda pelo médico	Multiusuário na internet; hospedagem a definir (região Brasil desejável)
Motor de regras (nome de trabalho: SAFE)	Classifica estado (repouso, atividade, exercício, sono), aplica limiares, cruza FC + SpO_2 + movimento e usa **baseline individual adaptativo**	Estratégia anti-falso-positivo: qualidade de sinal, 2–3 leituras, contexto. Resumo dos limiares no Anexo B
Alertas	WhatsApp e e-mail (outros canais previstos); escalonamento para crítico em estudo	Mensagens com dado mínimo (sem valores de FC/SpO_2)
Portais	Site público; área do cliente (login); console para médicos e instituições	Simulador de regras e mensagens para médicos e B2B logados

3. Público e modelo comercial

Segmento	Quem	Papel
B2C	Idosos	Usuário monitorado (titular dos dados); baixa afinidade tecnológica; consentimento é ponto sensível
B2C	Filhos e cuidadores	Frequentemente o contratante; recebem alertas
B2C	Médicos	Canal de indicação e usuários do console; vendem/indicam aos pacientes
B2B	Hospitais, clínicas, casas de repouso (ILPI)	Contratantes institucionais; provável papel de controlador dos dados dos seus pacientes/residentes

Canal médico — decisão atual: modelo A (o médico indica sem remuneração e recebe o console gratuitamente; tema a ser rediscutido com os sócios). Alternativas analisadas: **B** (telemonitoramento como serviço do médico, Vitalis cobra SaaS + dispositivo) e **C** (comissão por indicação — **não recomendada** sem parecer prévio por risco ético/regulatório).

4. Estratégia regulatória proposta (a validar)

A finalidade de uso declarada (o que o produto promete, como é anunciado e vendido) é o eixo da classificação. Avisos como “pode conter erros” e “não substitui avaliação médica” são úteis para transparência, mas **não substituem** a análise de enquadramento.

Estratégia	Descrição	Prós	Contras
1. Bem-estar estrito	Somente B2C, sem limiares clínicos, sem console médico	Rápido, sem registro	Conflita com canal médico e B2B hospitalar

Estratégia	Descrição	Prós	Contras
2. Duas camadas (proposta)	Camada 1: Vitalis Ring (bem-estar; avisos de “variação do seu padrão”, sem rótulo diagnóstico). Camada 2: módulo clínico (console, simulador, limiares) atrás de login, liberado após parecer	Permite avançar no beta; separa vocabulário e claims	Dois vocabulários e governanças; alerta idêntico nas duas camadas continua sendo a mesma finalidade
3. Assumir dispositivo médico	Regularizar hardware e software na ANVISA	Permite claims clínicos e venda hospitalar plena	Custo e prazo; exige evidências e sistema de qualidade

5. Funcionalidades na fronteira regulatória

Funcionalidade	Por que é sensível	Tratamento proposto (a validar)
Alertas por limiar de FC (bradicardia/taquicardia)	Limiares clínicos e níveis “importante/crítico” sugerem finalidade médica	Na camada 1, linguagem de variação do padrão individual; limiares clínicos só na camada 2
Oxigenação estimada (SpO_2) com faixas de hipoxemia	Oximetria é função regulada; anel de consumo tem acurácia limitada	Usar “oxigenação estimada”; verificar regularização do hardware e do sensor
Detecção de queda + “Você está bem?” + alerta a cuidador	Alerta a terceiros por evento de saúde; risco de falso negativo	Termos de não emergência; validar acurácia; parecer sobre enquadramento
Cruzamento FC + SpO_2 + movimento (ex.: “possibilidades: pneumonia, IC, TEP, sepse”)	Sugestão de hipóteses clínicas é linguagem diagnóstica	**Não** exibir hipóteses de doença ao usuário; uso interno de engenharia apenas
Relatório noturno (“padrão sugestivo de distúrbio respiratório do sono”)	Linguagem diagnóstica	Reescrever: “variações de oxigenação durante o sono, para conversar com seu médico”
Baseline individual adaptativo	Decisão automatizada com efeito sobre o titular (LGPD art. 20); “IA”	Descrever com transparência; permitir revisão; evitar “IA que detecta doenças”
Console médico e simulador (ajuste de limiares por paciente)	Configuração clínica de parâmetros = uso clínico do software	Versionamento, log de auditoria, limites mínimo/máximo definidos pela Vitalis; camada 2
Mensagens WhatsApp/e-mail	Dado de saúde em canal de terceiros	Dado mínimo; templates aprovados; consentimento do destinatário

6. Perguntas para a consultoria regulatória (ANVISA)

Referências a confirmar: RDC 657/2022 (software como dispositivo médico) e RDC 751/2022 (classificação de risco, notificação e registro), além de normas técnicas normalmente associadas (ex.: gestão de risco, ciclo de vida de software, cibersegurança).

1. Considerando as funcionalidades da seção 5, cada camada (bem-estar e clínica) se enquadra como dispositivo médico (hardware) e/ou software como dispositivo médico? Em que classe de risco?
2. Existe categoria reconhecida de produto de bem-estar geral? Quais claims e funcionalidades mantêm o produto fora do escopo regulado?
3. Notificações baseadas em limiares de FC/SpO_2, mesmo sem diagnóstico, caracterizam finalidade médica?
4. A função de SpO_2 em anel de consumo exige regularização? Quem seria o detentor (fabricante estrangeiro, importador ou a marca)?
5. Como é tratada a detecção de queda com alerta a terceiros?
6. O console médico com ajuste de limiares por paciente e o simulador precisam ser produto separado da camada de bem-estar?
7. Se houver registro ou notificação: prazos, custos, evidências exigidas (acurácia, estudo clínico) e requisitos de qualidade/tecnovigilância.

8. Existe caminho legal para um **beta** com usuários reais antes do registro (estudo, uso investigacional, limites de comunicação)?
9. A revenda B2B a hospitais/clínicas altera a análise? E o uso do termo “IA”?
10. Quais avisos obrigatórios ou recomendados (ex.: “estimativa automática, pode conter erros; não substitui avaliação médica; em emergência, ligue 192”)?

7. LGPD — perguntas e medidas propostas

Tema	Proposta atual	Pergunta ao jurídico
Base legal (dado sensível, art. 11)	Consentimento específico e destacado do titular	Basta o consentimento no B2C? Quando aplicar a hipótese de tutela da saúde?
Consentimento do idoso	Consentimento do próprio idoso; família só com base legal (ex.: curatela)	Como tratar idosos com capacidade reduzida? Impactos do Estatuto da Pessoa Idosa
Papéis	B2C: Vitalis controladora. B2B: instituição controladora, Vitalis operadora, com contrato (DPA)	Confirmar a divisão e as cláusulas obrigatórias
Governança	Encarregado (DPO), RIPD, registro das operações, plano de incidentes (art. 48)	Quem exerce o papel de DPO? Conteúdo mínimo do RIPD
Compartilhamento	Paciente, médico, família e instituição	Quais consentimentos e trilhas de auditoria?
Transferência internacional	Nuvem, WhatsApp (Meta), provedor de e-mail	Cláusulas e salvaguardas; preferência por região Brasil
Canais de alerta	Mensagens com dado mínimo; sem valores de saúde	Basta o consentimento do destinatário? Guarda das mensagens
Cookies e pixels	Site público com banner granular; **sem pixels de anúncio na área logada**	Regras para páginas públicas que tratem de saúde
Retenção e exclusão	Soft-delete, exclusão a pedido, retenção mínima	Prazos de guarda; logs (Marco Civil); portabilidade
Terceiros cadastrados	Usuário cadastra telefone/e-mail de cuidadores	Como o terceiro consente e como revoga?

8. Canal médico, ética e telemonitoramento

- O modelo A (indicação sem remuneração, console gratuito) precisa ser confrontado com o Código de Ética Médica e as normas de publicidade médica do CFM (referências a confirmar: Res. CFM 2.217/2018 e 2.336/2023).
- Telemonitoramento e acesso a dados por médicos: verificar a Res. CFM 2.314/2022 (telemedicina) e a relação médico-paciente criada pelo acesso ao console.
- **Expectativa de resposta:** se o médico recebe alertas, qual é o seu dever de atender em tempo real? Os termos precisam afirmar que o serviço **não é de emergência** nem monitorado 24h, salvo contrato específico.
- A vinculação paciente↔médico exige consentimento do paciente para o compartilhamento de dados (LGPD).
- Qualquer forma de remuneração/comissão (modelo C) exige parecer antes de qualquer tela ou contrato.

9. Propriedade intelectual e nome “Vitalis”

Decisão atual: não depositar a marca no INPI por ora; o domínio será registrado. **Ponto de atenção:** registrar domínio não confere direito de marca. No Brasil, a propriedade da marca decorre do registro (Lei 9.279/1996, art. 129, com direito de precedência para usuário anterior de boa-fé — a confirmar). “Vitalis” é nome comum em saúde e farma; o risco de colisão ou de terceiro registrar antes é real.

- **Ação de baixo custo recomendada:** busca de anterioridade no banco do INPI (e no domínio) **antes** de investir em identidade visual, materiais e site. Isso não exige depósito.

- Classes candidatas a discutir (Nice, a confirmar por profissional de PI): 9 (dispositivos/software), 10 (aparelhos médicos), 42 (SaaS), 44 (serviços de saúde).
- Definir a **titularidade** (qual CNPJ) da marca, do logotipo e do software.
- **Logotipo gerado por IA:** verificar titularidade autoral (obra sem autoria humana), termos de uso comercial do provedor e a necessidade de redesenho próprio do wordmark. O wordmark final será refeito em SVG.
- Nome do motor de regras (“SAFE”) e tagline (“Care that connects” / “Cuidado que conecta”): incluir na mesma busca.
- Perguntas: parecer de colidência; estratégia e momento do depósito; risco de adiar; proteção de nome de domínio e redes sociais.

10. Publicidade, comunicação e imagens

- Referências a confirmar: CDC (Lei 8.078/1990), arts. 36–38 — identificação e veracidade da publicidade, com **ônus da prova** de quem anuncia; Código do CONAR (veracidade e respeitabilidade); normas do CFM sobre publicidade médica.
- Regras práticas adotadas: sem promessa de resultado; sem “clinicamente validado” sem estudo; sem logos ou nomes de entidades (AHA, ESC, ATS, AASM) como aval — usar “inspirado em boas práticas”; sem alegar diagnóstico.
- **Imagens geradas por IA:** o autor do dossiê não identificou, em pesquisa preliminar, regra brasileira geral que obrigue o uso de fotos de pessoas reais. O risco está em apresentar pessoas sintéticas como **clientes, pacientes ou médicos reais** (depoimentos, casos, “Dr. X recomenda”), o que pode caracterizar publicidade enganosa.
- Política adotada: imagens de ambiente, mãos e produto; quando houver pessoas, legenda “Imagem ilustrativa”; **nenhum depoimento, caso ou médico fictício**. Acompanhar a evolução do marco legal de IA (PL 2338/2023) e eventuais regras de rotulagem.
- Aviso padrão em alertas e páginas: “Estimativa automática. Pode conter erros. Não substitui avaliação médica. Em emergência, ligue 192.”

11. Termos, contratos e terceiros

Item	Ponto a resolver
Termos de Uso e Política de Privacidade (B2C)	Não é serviço de emergência; limitação de responsabilidade; consentimentos; direitos do titular
Contrato B2B	DPA, SLA, escopo de alertas, papéis LGPD, responsabilidade, protocolo de escalonamento
Fabricante OEM (anel)	Contrato de fornecimento, garantia, responsabilidade pelo produto (CDC), rastreabilidade
Homologação de telecomunicações	Equipamento com Bluetooth à venda no Brasil: verificar homologação na Anatel e outras certificações aplicáveis (ex.: bateria)
Meta/WhatsApp Business	Verificar política vigente para conteúdo de saúde; opt-in; templates; custo por mensagem
Nuvem e e-mail transacional	Contrato de operador, subprocessadores, região, transferência internacional
Seguros	Responsabilidade civil profissional/produto e seguro cibernético

12. Pendências e decisões em aberto

#	Item	Responsável	Status
1	Validar os demais recursos que o anel entrega (outro chat) e trazer como base	Dimmy	Pendente — **não bloqueia**; sinalizar antes do beta

#	Item	Responsável	Status
2	Busca de anterioridade INPI para “Vitalis” e “SAFE”	Jurídico/PI	Pendente
3	Registro do domínio	Dimmy	Decidido registrar
4	Parecer regulatório (seção 6) e definição da estratégia (duas camadas)	Consultoria + sócios	A contratar / a validar
5	Rediscutir modelo do canal médico com os sócios (atual: A)	Sócios	Pendente
6	Termos de Uso, Política de Privacidade, contrato B2B com DPA	Jurídico	Pendente
7	RIPD e designação do encarregado (DPO)	Jurídico/DPO	Pendente
8	Homologação Anatel e demais certificações do anel	Fornecedor/importador	Pendente
9	Política da Meta para saúde; escolha do provedor de WhatsApp	Dimmy/Jurídico	Pendente
10	Aprovação do guia de copy (Anexo A) antes de publicar o site	Jurídico	Pendente
11	Titular jurídico do produto (CNPJ)	Sócios	Pendente

Anexo A — Guia de copy (site, alertas e mensagens)

Diga	Evite
“Avisa quando algo sai do seu padrão”	“Detecta bradicardia, hipoxemia, FA”
“Oxigenação estimada”	“Oximetria”, “diagnóstico”, “previne infarto/AVC”
“Estimativa automática. Pode conter erros. Não substitui avaliação médica.”	“Precisão médica”, “clinicamente validado” (sem estudo)
“Informações para conversar com seu médico”	“Substitui consulta ou monitoramento hospitalar”, “salva vidas”
“Variações de oxigenação durante o sono”	“Padrão sugestivo de distúrbio respiratório do sono”
“Inspirado em boas práticas de cardiologia”	Logos ou nomes AHA/ESC/ATS/AASM como aval
“Avisa sua família e seus contatos”	“Alerta clínico”, “alerta crítico” em copy público
Imagens de ambiente, mãos e produto; legenda “Imagem ilustrativa”	Depoimentos, casos ou médicos fictícios; pessoas sintéticas apresentadas como reais
“Inteligência adaptativa que aprende o seu padrão”	“IA que detecta doenças”

Anexo B — Resumo das regras de alerta (documento interno “Regra inicial de negócio”)

Estes limiares e rótulos são o que mais pesa na análise de finalidade de uso. Níveis de status: **Normal** (verde), **Leve/silencioso** (azul), **Moderado** (amarelo), **Importante** (laranja), **Crítico** (vermelho).

Bradicardia — acordado e em repouso

FC	Persistência	Ação
≥ 50 bpm	—	Normal
45–49 bpm	> 3 min	Notificação silenciosa
40–44 bpm	> 60 s	Alerta moderado
≤ 40 bpm	> 30 s	Alerta importante
≤ 35 bpm	Qualquer momento	Alerta crítico

Bradicardia durante o sono

FC	Persistência	Ação
40–50 bpm	—	Fisiológico
< 35 bpm	> 2 min	Alerta silencioso matinal
< 30 bpm	Sustentado	Alerta importante

Taquicardia — repouso confirmado, sem exercício

FC	Persistência	Ação
> 100 bpm	> 10 min	Notificação leve
> 120 bpm	> 5 min	Alerta moderado
≥ 140 bpm	> 2 min	Alerta importante
≥ 160 bpm	> 60 s	Alerta crítico

Saturação de O_2 — leituras válidas e estáveis

SpO_2	Persistência	Ação
≥ 93%	—	Normal
90–92%	> 5 min	Alerta leve
≤ 90%	> 60 s	Alerta moderado
≤ 88%	> 30–60 s	Alerta importante
≤ 85%	> 15–30 s	Alerta crítico

Integrações e queda

Situação	Ação
FC alta + SpO_2 baixa em repouso (ex.: FC 130, SpO_2 88%)	Alerta prioritário
Bradicardia + imobilidade (ex.: FC 35 sem movimento)	Alerta crítico imediato
Dessaturação noturna recorrente (< 90%)	Relatório (linguagem a reescrever, ver Anexo A)
Queda + ausência de movimento > 60 s	Pergunta “Você está bem?”; sem resposta, alerta a cuidador/familiar

Observação de especificação: o documento-fonte sobrepõe fronteiras nos valores 40 bpm (moderado × importante) e 90% (leve × moderado). Definir os operadores (< ou ≤) na especificação técnica antes de implementar o motor.